VIH, CD4 et sida · Cartes 1 à 5 / 50

VIH, CD4 et sida

01

QUESTION

Qu'est-ce que le VIH ?

RÉPONSE

Le virus de l'immunodéficience humaine est un rétrovirus. Il a besoin d'une cellule hôte pour se multiplier ; son ADN peut s'intégrer au génome de la cellule.

VIH, CD4 et sida

02

QUESTION

Pourquoi les antirétroviraux ne guérissent-ils pas habituellement le VIH ?

RÉPONSE

Ils bloquent la réplication, mais l'ADN viral intégré peut persister dans des réservoirs. Une charge virale indétectable n'équivaut pas à une éradication.

VIH, CD4 et sida

03

QUESTION

Qu'est-ce qu'un lymphocyte T CD4 ?

RÉPONSE

C'est un globule blanc qui coordonne les réponses immunitaires : un « chef d'orchestre » de l'immunité. Il n'est ni une hormone ni un anticorps.

VIH, CD4 et sida

04

QUESTION

Pourquoi le VIH expose-t-il aux infections opportunistes ?

RÉPONSE

Il cible et détruit progressivement les lymphocytes T CD4. Les défenses immunitaires diminuent et certaines infections deviennent plus probables.

VIH, CD4 et sida

05

QUESTION

Charge virale et nombre de CD4 : quelle différence ?

RÉPONSE

La charge virale mesure l'ARN du VIH circulant ; le nombre de CD4 renseigne sur l'état immunitaire. Ce sont deux marqueurs complémentaires.

VIH, CD4 et sida

06

QUESTION

Qu'appelle-t-on « ADN proviral » ?

RÉPONSE

L'ADN du VIH intégré dans le génome de cellules infectées. Il participe à la persistance du virus et ne se confond pas avec l'ARN viral circulant.

VIH, CD4 et sida

07

QUESTION

Que signifie le repère de 200 CD4/mm³ ?

RÉPONSE

Au-dessous d'environ 200 CD4/mm³, le risque d'infections opportunistes augmente fortement. Ce seuil ne suffit pas, à lui seul, à définir automatiquement le stade sida.

VIH, CD4 et sida

08

QUESTION

Quelle différence entre être séropositif au VIH et avoir le sida ?

RÉPONSE

On peut vivre avec le VIH sans être au stade sida. Le sida correspond à un stade avancé défini par certains critères, notamment des maladies opportunistes caractéristiques.

VIH, CD4 et sida

09

QUESTION

Une infection opportuniste signifie-t-elle toujours « sida » ?

RÉPONSE

Non. Elle peut survenir chez une personne immunodéprimée pour une autre raison, par exemple après une greffe. Le diagnostic de sida est lié à l'infection par le VIH.

VIH, CD4 et sida

10

QUESTION

Pourquoi employer le terme « PVVIH » ?

RÉPONSE

Il signifie « personne vivant avec le VIH ». Il évite de réduire la personne à son infection et soutient une relation de soin sans stigmatisation.

Transmission et évolution clinique · Cartes 11 à 15 / 50

Transmission et évolution clinique 11

QUESTION

Quelles sont les principales voies de transmission du VIH ?

RÉPONSE

La transmission est surtout sexuelle en France. La transmission sanguine et la transmission parent-enfant sont aussi possibles selon les situations.

Transmission et évolution clinique 12

QUESTION

Le contact ordinaire avec une PVVIH transmet-il le VIH ?

RÉPONSE

Non. Un examen clinique courant ou le contact social n'est pas une exposition au VIH. Les soins reposent sur les précautions standard pour toutes les personnes.

Transmission et évolution clinique 13

QUESTION

Qu'est-ce que le principe « I = I » ?

RÉPONSE

« Indétectable = intransmissible » : sous traitement efficace, avec suppression virale durablement contrôlée, le VIH n'est pas transmis lors des rapports sexuels.

Transmission et évolution clinique 14

QUESTION

I = I dispense-t-il de prévenir les autres IST ?

RÉPONSE

Non. Le principe porte sur la transmission sexuelle du VIH sous suppression virale durable ; il ne protège pas des autres IST ni ne remplace les précautions standard.

Transmission et évolution clinique 15

QUESTION

Quand survient généralement la primo-infection VIH ?

RÉPONSE

La séance situe ses manifestations possibles environ 2 à 6 semaines après la contamination. Elle peut rester asymptomatique ou ressembler à une grippe.

Transmission et évolution clinique

16

QUESTION

Quels signes doivent faire évoquer une primo-infection ?

RÉPONSE

Fièvre, céphalées, pharyngite, éruption, ganglions ; parfois anomalies biologiques. Ces signes sont non spécifiques et ne permettent pas seuls de diagnostiquer le VIH.

Transmission et évolution clinique

17

QUESTION

Qu'est-ce que la latence clinique du VIH ?

RÉPONSE

Une période parfois longue avec peu ou pas de symptômes. Le virus demeure présent et peut continuer à se répliquer : « asymptomatique » ne signifie pas « indétectable ».

Transmission et évolution clinique

18

QUESTION

Comment évolue le VIH sans traitement ?

RÉPONSE

Après la primo-infection et une période de latence possible, les CD4 diminuent progressivement et les complications immunitaires peuvent apparaître.

Transmission et évolution clinique

19

QUESTION

Pourquoi une personne traitée peut-elle mener une vie proche de la normale ?

RÉPONSE

Le traitement contrôle la réplication, permet généralement la remontée des CD4 et réduit le risque de complications. L'observance et le suivi restent essentiels.

Transmission et évolution clinique

20

QUESTION

Quelles complications autres qu'infectieuses sont évoquées ?

RÉPONSE

Un risque accru de certains cancers et de maladies cardiovasculaires, favorisé notamment par l'inflammation liée à une infection non contrôlée.

Infections opportunistes et complications · Cartes 21 à 25 / 50

Infections opportunistes et complications 21

QUESTION

Qu'appelle-t-on « infection opportuniste » ?

RÉPONSE

Une infection favorisée par un affaiblissement des défenses immunitaires. Chez une PVVIH très immunodéprimée, certaines infections peuvent révéler un stade sida.

Infections opportunistes et complications 22

QUESTION

Que provoque la pneumocystose ?

RÉPONSE

Cette infection fongique atteint surtout les poumons et peut entraîner toux, fièvre, dyspnée et détresse respiratoire. Elle peut nécessiter des soins intensifs.

Infections opportunistes et complications 23

QUESTION

Quelle prévention de la pneumocystose est citée ?

RÉPONSE

Une prophylaxie par cotrimoxazole (Bactrim) chez des personnes dont les CD4 sont très bas, notamment sous le repère des 200/mm³, selon la décision médicale.

Infections opportunistes et complications 24

QUESTION

Quels signes peuvent révéler une toxoplasmose cérébrale ?

RÉPONSE

Déficit neurologique focal, hémiplégie ou crise convulsive, parfois tableau évoquant un AVC. L'imagerie peut montrer des lésions intracérébrales.

Infections opportunistes et complications 25

QUESTION

Quelle atteinte évoque une cryptococcose chez une PVVIH ?

RÉPONSE

Une méningite avec céphalées et fièvre, parfois hypertension intracrânienne. L'enseignante évoque surtout les immunodépressions profondes et des ponctions lombaires répétées.

Infections opportunistes et complications · Cartes 26 à 30 / 50

Infections opportunistes et complications 26

QUESTION

Quelles atteintes typiques du CMV sont citées ?

RÉPONSE

Rétinite pouvant menacer la vision et colite avec diarrhées importantes. D'autres atteintes, notamment neurologiques, sont possibles.

Infections opportunistes et complications 27

QUESTION

Quel dépistage faut-il penser à proposer devant une tuberculose ?

RÉPONSE

Un dépistage du VIH. L'enseignante insiste explicitement : rechercher une éventuelle infection VIH chez toute personne atteinte de tuberculose.

Infections opportunistes et complications 28

QUESTION

Quelles précautions devant une tuberculose pulmonaire contagieuse ?

RÉPONSE

Des précautions « Air », et non simplement « gouttelettes », selon les protocoles de soins. La prévention du risque respiratoire est une priorité.

Infections opportunistes et complications 29

QUESTION

La tuberculose ne survient-elle que lorsque les CD4 sont très bas ?

RÉPONSE

Non. Elle peut apparaître à différents stades de l'infection VIH, y compris avant une immunodépression profonde.

Infections opportunistes et complications 30

QUESTION

Quel cancer est associé à HHV-8 dans la séance ?

RÉPONSE

La maladie de Kaposi, illustrée par des nodules cutanés violacés. Sont aussi évoqués les lymphomes et certains cancers liés au papillomavirus.

Dépistage, traitement et maternité · Cartes 31 à 35 / 50

Dépistage, traitement et maternité 31

QUESTION

Quels examens sont évoqués pour dépister le VIH ?

RÉPONSE

La sérologie sanguine et des tests rapides (TROD, autotests). Le choix du test et son interprétation dépendent notamment du contexte d'exposition.

Dépistage, traitement et maternité 32

QUESTION

Comment interpréter un autotest VIH réactif ?

RÉPONSE

Un résultat positif ou réactif sur un test rapide doit être confirmé par un examen biologique adapté. Il ne doit pas être présenté seul comme diagnostic définitif.

Dépistage, traitement et maternité 33

QUESTION

Que suit-on régulièrement chez une PVVIH traitée ?

RÉPONSE

La charge virale, les CD4 et l'état clinique. La séance cite comme objectif de suppression une charge virale inférieure à 50 copies/mL.

Dépistage, traitement et maternité 34

QUESTION

Pourquoi rechercher d'autres IST chez une PVVIH ?

RÉPONSE

Les expositions peuvent concerner plusieurs infections. La séance cite notamment hépatites B et C, syphilis, chlamydia et gonocoque.

Dépistage, traitement et maternité 35

QUESTION

Quand et pendant combien de temps traiter le VIH ?

RÉPONSE

Débuter les antirétroviraux dès que possible et poursuivre au long cours, en principe à vie. Une interruption peut laisser la réplication reprendre et les CD4 baisser.

Dépistage, traitement et maternité · Cartes 36 à 40 / 50

Dépistage, traitement et maternité 36

QUESTION

« Trithérapie » signifie-t-il toujours trois comprimés ?

RÉPONSE

Non. Certaines associations contiennent 2 ou 3 molécules dans un seul comprimé quotidien ; des traitements injectables existent aussi dans des indications choisies.

Dépistage, traitement et maternité 37

QUESTION

Quels exemples de traitements combinés sont cités ?

RÉPONSE

Biktarvy, Dovato et Delstrigo. Leur composition et leur indication diffèrent : le schéma est individualisé par le prescripteur.

Dépistage, traitement et maternité 38

QUESTION

Une PVVIH contrôlée peut-elle envisager une grossesse spontanée ?

RÉPONSE

Oui. Le contrôle virologique peut permettre un projet de grossesse sans recours systématique à la PMA, avec un suivi spécialisé du couple et de la grossesse.

Dépistage, traitement et maternité 39

QUESTION

Quel est le principe de prévention mère-enfant ?

RÉPONSE

Maintenir une charge virale maternelle contrôlée, assurer le suivi spécialisé et proposer les mesures adaptées au nouveau-né, dont la prophylaxie selon le contexte.

Dépistage, traitement et maternité 40

QUESTION

Allaitement et VIH : quel raisonnement retenir ?

RÉPONSE

L'allaitement peut être discuté dans des situations sélectionnées et suivies de près ; il n'est pas automatiquement interdit. Le risque résiduel et les modalités relèvent de l'équipe spécialisée.

PrEP, TPE et rôle infirmier · Cartes 41 à 45 / 50

PrEP, TPE et rôle infirmier

41

QUESTION

Que signifie « PrEP » ?

RÉPONSE

Prophylaxie pré-exposition : utilisation préventive d'antirétroviraux chez une personne sans VIH avant certaines expositions à risque.

PrEP, TPE et rôle infirmier

42

QUESTION

Quelles modalités de PrEP sont présentées ?

RÉPONSE

La séance évoque des schémas oraux continus ou à la demande, et des traitements injectables. Leur choix dépend de l'indication et du suivi spécialisé.

PrEP, TPE et rôle infirmier

43

QUESTION

La PrEP protège-t-elle des autres IST ?

RÉPONSE

Non. Elle vise la prévention du VIH, mais ne remplace ni le préservatif, ni le dépistage et le suivi des autres IST.

PrEP, TPE et rôle infirmier

44

QUESTION

PrEP et TPE : quelle différence ?

RÉPONSE

PrEP : prévention organisée AVANT une exposition éventuelle. TPE/PEP : traitement urgent proposé APRÈS une exposition potentielle, selon l'évaluation médicale.

PrEP, TPE et rôle infirmier

45

QUESTION

Quels délais de TPE sont donnés à l'oral ?

RÉPONSE

Le plus tôt possible après l'exposition : idéalement dans les 4 heures et au plus tard dans les 72 heures. La séance indique une durée de 28 jours.

PrEP, TPE et rôle infirmier · Cartes 46 à 50 / 50

PrEP, TPE et rôle infirmier 46

QUESTION

Quelles analyses accompagnent un TPE ?

RÉPONSE

Un bilan initial, notamment VIH et hépatites selon la situation, puis des contrôles ultérieurs. La séance cite un contrôle à 6 semaines ; le calendrier exact suit le protocole.

PrEP, TPE et rôle infirmier 47

QUESTION

Que faire administrativement après un AES professionnel ?

RÉPONSE

Ne pas oublier la déclaration d'accident du travail, en plus de la prise en charge urgente et du suivi médical prévus par le protocole.

PrEP, TPE et rôle infirmier 48

QUESTION

Quelles données recueillir après un rapport ou un AES à risque ?

RÉPONSE

La date et l'heure, le type d'exposition, les protections utilisées et les informations utiles sur la source. Elles servent à orienter rapidement l'évaluation du TPE.

PrEP, TPE et rôle infirmier 49

QUESTION

Quelles précautions infirmières chez une PVVIH ?

RÉPONSE

Appliquer les précautions standard comme pour tous : pas de protection supplémentaire pour le contact ordinaire ; gants et matériel sécurisé lors d'actes exposant au sang.

PrEP, TPE et rôle infirmier 50

QUESTION

Quelles dimensions composent le suivi global d'une PVVIH ?

RÉPONSE

Éducation thérapeutique, soutien psychologique, aide sociale, médiation en santé, vaccinations et suivi régulier, avec une attitude non jugeante.